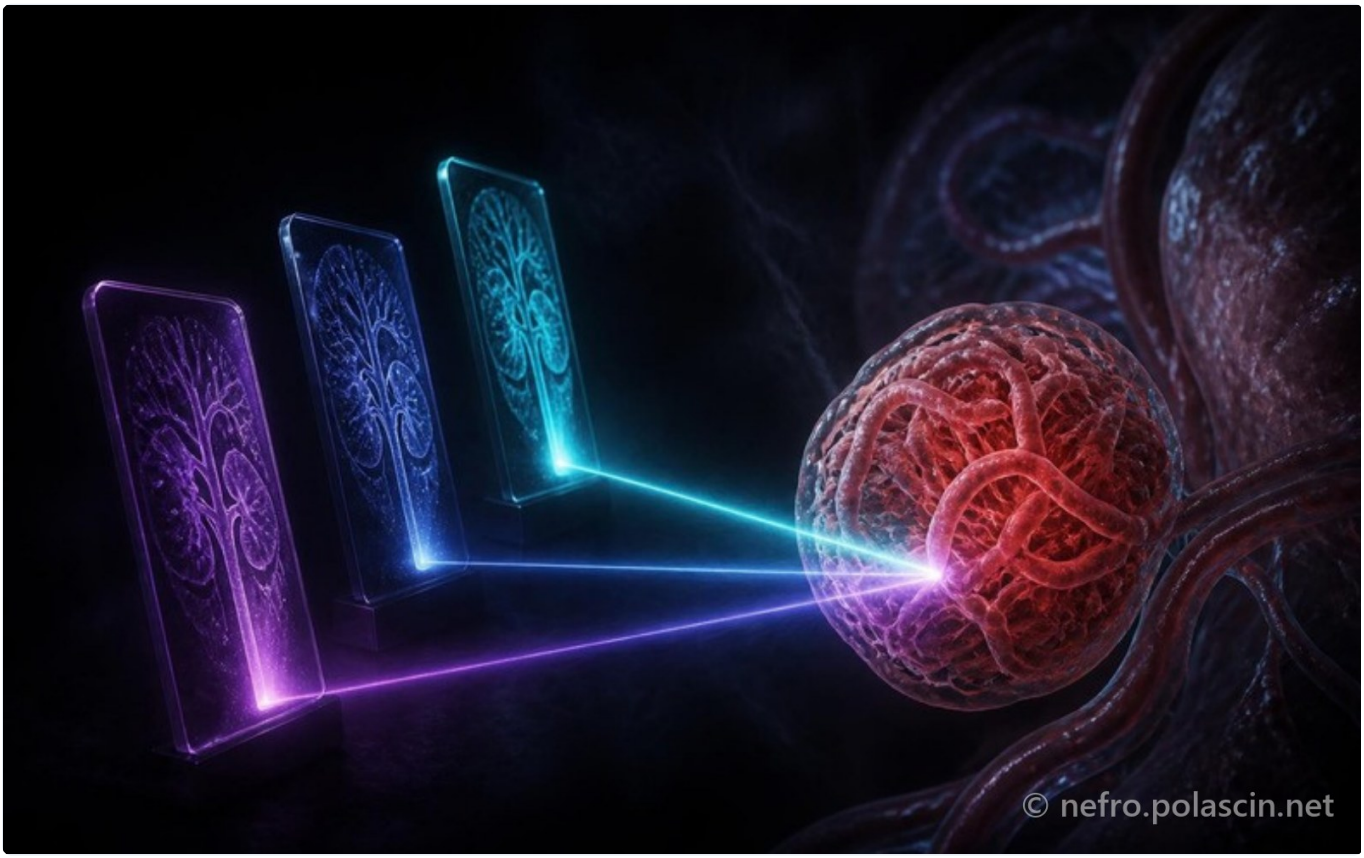
Porovnanie troch hlavných usmernení pre lupusovú nefritídu: ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Cieľ je spoločný, cesty sa mierne líšia – a rozdiely medzi usmerneniami treba poznať.

Nedávna porovnávacia analýza ukazuje, že tri „veľké“ medzinárodné odporúčania pre lupusovú nefritídu (LN) vychádzajú zo spoločného dôkazového základu, no v niekoľkých bodoch sa významne rozchádzajú. Rozdiely sa premietajú do výberu režimu, do toho, akú váhu dostane klinický profil pacienta, aj do cieľov liečby v čase. Text sumarizuje hlavné zhody a rozdiely z pohľadu klinickej praxe.

Diagnostika a sledovanie: rovnaký princíp, odlišná operacionalizácia

Všetky tri usmernenia podporujú prísne sledovanie renálneho postihnutia u pacientov so systémovým lupus erythematosus (SLE).

- **ACR** preferuje **fixný harmonogram** hodnotení každých **6 až 12 mesiacov**.
- **EULAR aj KDIGO** idú skôr cestou **individualizovaného, rizikovo orientovaného monitorovania**.

Biopsiu obličky pri podozrení na LN odporúčajú všetky tri zdroje, najmä vtedy, ak:

- proteinúria presahuje **0,5 g/deň**, alebo
- dochádza k **poklesu funkcie obličiek**.

KDIGO pritom kladie väčší dôraz na **detailné, „kompartmentové“ histologické hodnotenie**, aby sa liečba dala cielene prispôsobiť.

Úvodná imunosupresia pri proliferatívnej LN: zhoda na eskalácii, rozdiel vo východiskovom režime

Pri proliferatívnej forme LN všetky tri usmernenia podporujú **včasnú a intenzívnu kombinovanú liečbu**.

Spoločný základ

- **hydroxychlorochín (HCQ)** ako základ liečby,
- **glukokortikoidy** s dôrazom na **rýchlu minimalizáciu dávky steroidov**.

Všetky tri rámce uvádzajú použitie **krátkych intravenóznych pulzov metylprednizolónu** (v rozmedzí **250 až 1000 mg denne počas najviac 3 dní**), následne prechod na perorálne glukokortikoidy a **zrýchlené znižovanie dávky (taperovanie)** tak, aby sa približne do **4 až 6 mesiacov** dosiahla dávka **5 mg/deň alebo nižšia**.

Odlišnosti v úvodných režimoch (trojkombinácia verzus dvojkombinácia)

Práve tu sú rozdiely klinicky najvýznamnejšie:

- **ACR** preferuje **úvodnú trojkombináciu**, typicky s **mykofenolát-mofetilom (MMF)** a pridaním **buď belimumabu, alebo kalcineurínového inhibítora (CNI)**.
- **EULAR** tiež podporuje skorú intenzívnu liečbu, no ako prvú líniu uvádza **MMF + obinutuzumab**; v tom sa prakticky najviac líši od ACR aj KDIGO, ktoré obinutuzumab do odporúčaní nezahŕňajú.
- **KDIGO** explicitne uznáva ako prvú líniu aj **dvojkombináciu**, ktorá môže zahŕňať **nízkodávkovaný cyklofosfamid** alebo **MMF**.

Rituximab a obinutuzumab

- **Rituximab** nie je odporúčaný ako prvá línia v žiadnom z troch usmernení; dôvodom sú negatívne výsledky štúdie **LUNAR**.
- **Obinutuzumab** je naopak špecifický pre EULAR, čo odráža rozdiely v interpretácii a zapracovaní dostupných údajov.

Klinické profilovanie: ACR najpreskriptívnejšie, EULAR opatrnejšie

Rozdiely sa netýkajú len toho, aký liek zvoliť, ale aj toho, **ako striktne** sa má rozhodovanie opierať o klinický profil pacienta.

- **ACR** poskytuje **najkonkrétnejšie odporúčania**:
  - pri **ťažkej proteinúrii (3 g/deň alebo viac)** preferuje režimy založené na **CNI**,
  - pri **výraznom extrarenálnom postihnutí** alebo pri **zníženej funkcii obličiek** uprednostňuje **belimumab**.
- **KDIGO** tiež zohľadňuje charakteristiky pacienta (vrátane napríklad **etnicity** a **rizika recidívy**), no je **menej preskriptívne** v konkrétnych algoritmoch.
- **EULAR** pristupuje **opatrnejšie**: zdôrazňuje, že niektoré „profilové“ závery môžu stáť na *post-hoc* analýzach s obmedzenou interpretáciou.

Liečebné ciele a časové rámce: zhoda na „kompletnej odpovedi“, rozdiel v tempe hodnotenia

Všeobecná zhoda je v definícii:

- **kompletná renálna odpoveď**: **proteinúria < 0,5 g/deň** pri stabilnej funkcii obličiek.

Tempo, do ktorého sa má tento cieľ dosiahnuť, však vnímajú odlišne:

- **KDIGO aj ACR** zdôrazňujú dosiahnutie v horizonte **6 až 12 mesiacov**.
- **EULAR** používa praktickejší priebežný cieľ: **proteinúria < 0,7 g/deň v 12. mesiaci** ako referenčný bod na rutinné vyhodnotenie.

Súhrnné porovnanie

Oblasť	ACR	EULAR	KDIGO

Oblasť	ACR	EULAR	KDIGO
Monitorovanie	Skôr **fixný harmonogram** hodnotení (typicky každých **6 až 12 mesiacov**)	Viac **individualizovaný, rizikovo orientovaný** prístup	Rizikovo orientované monitorovanie, praktický dôraz na načasovanie
Prvolíniový režim (proliferatívna LN)	Skôr **úvodná trojkombinácia** (HCQ + glukokortikoidy + imunosupresia; jadro často **MMF**, doplnenie podľa profilu: **belimumab alebo CNI**)	Skôr **MMF + obinutuzumab** (v komparácii uvádzané ako kľúčový rozdiel)	Uznáva aj **dvojkombináciu** ako prvú líniu (napr. **nízkodávkovaný cyklofosfamid** alebo **MMF**)
Miesto obinutuzumabu	Nie je východiskový v prvej línii	**Súčasť prvej línie**	Nie je v jadre odlišujúcim prvkom oproti ostatným v tejto komparácii
Miesto rituximabu	Nie ako prvá línia (uvádza sa negatívny dosah dát typu **LUNAR**)	Nie ako prvá línia	Nie ako prvá línia v rámci komparácie
Profilovanie pacienta	**Najpreskriptívnejšie** odporúčania podľa profilu (napr. váha proteinúrie)	**Opatrnejšie** pri profilových záveroch	Zohľadňuje viac faktorov, no je **menej algoritmické** v detailoch
Liečebný cieľ a časový rámec	Kompletná renálna odpoveď: **proteinúria < 0,5 g/deň** pri stabilnej funkcii; hodnotenie v horizonte **6 až 12 mesiacov**	Praktický cieľový rámec; uvádza sa referenčný bod **proteinúria < 0,7 g/deň v 12. mesiaci**	Kompatibilné s rámcom kompletnej renálnej odpovede a hodnotením v horizonte **6 až 12 mesiacov**
Biopsia a histológia	Biopsia najmä pri podozrení na aktívnu LN so závažnejšími parametrami (prah typicky **proteinúria > 0,5 g/deň** a/alebo pokles funkcie)	Podobný koncept potreby biopsie pri klinickej indikácii	Biopsia s dôrazom na detailné „kompartmentové“ histologické hodnotenie pre čo najcielenejšiu liečbu
Eskalačné kroky / zmena stratégie	Po úvodnej imunosupresii sa nastavuje tempo hodnotenia (6 až 12 mesiacov); pri nedostatočnej odpovedi sa zvažuje úprava stratégie (presun medzi režimami / eskalácia intenzity)	Podobný princíp s dôrazom na priebežné vyhodnotenie odpovede v čase a následnú úpravu podľa rizika a odpovede	Dôraz na štruktúrovanú stratifikáciu; pri nedostatočnej odpovedi logika „uprav a prehodnoť“ (úprava typu a intenzity imunosupresie)
Rezervné lieky (nie prvá línia)	Rituximab nie je prvá línia; skôr neskoršia/alternatívna možnosť pri zlyhaní alebo intolerancii prvolíniových prístupov	Rituximab tiež nie je prvá línia (komparácia rieši najmä jeho neštandardnosť ako prvolíniovej liečby)	Rituximab tiež nie je prvá línia; neskoršie použitie závisí od klinického kontextu
Nefroprotekcia	Spoločný rámec: kontrola krvného tlaku, **blokáda RAAS**, selektívne zváženie **inhibítorov SGLT2**	Rovnaký princíp – praktická nefroprotekcia popri imunosupresii	Rovnaký spoločný základ: cieľový krvný tlak, RAAS, selektívne SGLT2

Membranózna (trieda V) LN: najväčšie medzery v dôkazoch

Pri triede V porovnanie otvorene ukazuje nedostatok spoľahlivých údajov:

- naprieč odporúčaniami **neexistuje všeobecne prijatá stratégia**,
- **EULAR** lieči triedu V podobne ako proliferatívne ochorenie,
- **ACR a KDIGO** sa viac riadia závažnosťou proteinúrie:
    - pri proteinúrii **> 1 g/deň** ACR odporúča **úvodnú trojkombináciu** (glukokortikoidy + MMF + CNI),
    - KDIGO preferuje **dvojkombinovanú imunosupresiu**.

Triedy I–II LN: praktická šedá zóna

- pre **triedy I a II** usmernenia podľa porovnania nedávajú explicitné odporúčania (ide o „šedú zónu“),

- **KDIGO** však spomína koncept **lupusovej podocytopatie** u pacientov s triedou I–II, ak sa pridá **nefrotická proteinúria** alebo **nefrotický syndróm**,
- pri recidívach KDIGO odporúča udržiavaciu stratégiu: **nízkodávkové glukokortikoidy** a ďalší imunosupresívny liek (**MMF, azatioprín alebo CNI**).

Renoprotektívna liečba: spoločný rámec bez ohľadu na hlavný režim

Okrem imunosupresie všetky tri dokumenty zdôrazňujú nefroprotekciu:

- kontrola krvného tlaku na približne **< 120–130/80 mmHg**,
- **blokáda systému renín-angiotenzín (RAAS)**,
- selektívne zváženie **inhibítorov SGLT2**.

Praktický dosah do bežnej ambulancie

Z porovnania vyplýva jedno: hoci cieľ je spoločný (včas potlačiť aktívnu zápalovú aj fibrotizujúcu kaskádu a udržať bezpečnosť liečby), **spôsob, akým sa volí režim**, sa môže líšiť podľa toho:

- či sa ako východisko preferuje trojkombinácia alebo dvojkombinácia,
- akú váhu dostane klinické profilovanie,
- a aké tempo sa nastaví pre hodnotenie odpovede.

To vysvetľuje, prečo sa v odbornej komunite stále diskutuje, či by sa štandardom mala stať „trojkombinácia pre všetkých“, alebo či je lepšie flexibilné, rizikovo orientované prispôsobenie.

Zdroj: *Nephrology Dialysis Transplantation (komparatívny článok referovaný v Renal & Urology News): „Three Major Lupus Nephritis Guidelines Agree, Differ on Treatment“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=porovnanie-usmerneni-lupusova-nefritida-acr-eular-kdigo · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.